1. CONCEITO: Presença de microrganismo identificado em amostra de urina em pacientes com sinais ou sintomas de infecção;

1.1 Responsáveis pela execução

Profissionais de saúde assistencialistas.

1.2 Finalidade

- Padronizar a implementação de medidas de prevenção e controle de Infecção do trato urinário associada à assistência à saúde, com o obetivo de reduzir essas infecções e promover maior segurança aos pacientes.

1.3 Indicações

Pacientes internados nesta unidade de saúde.

2. MATERIAIS

- Preparação alcoolica ou sabonete líquido
- EPIs
- Kit de cateterismo e inserção estéril
- Bundlle de inserçao de CVD
- Bundlle de manutenção de CVD

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 MEDIDAS GERAIS

✓ **Higiene das mãos**

- Estimular a prática da higienização de mãos nos cinco mo mentos, preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com preparação alcoólica ou água e sabonete líquido, e conforme orientações da Anvisa.

✓ **Aplicação do Bundle de Manutenção de Cateter Vesical**

- Executar, diariamente, o bundle de Manutenção do Cateter Vesical e registrar em prontuário eletrônico (SOUL MV).

✓ **Visitas multidisciplinares**

- Realizar visitas multidisciplinares diariamente, com participação de profissionais envolvidos na assistência direta aos pacientes, visando avaliação das práticas assistenciais relacionadas ao uso de CVD.

✓ **Engajamento de Pacientes e Familiares**

- Informar ao paciente e acompanhantes sobre a indicação do CVD, riscos de infecção e cuidados necessários;
- Orientar quanto a importância da higiene íntima, da higienização das mãos nos momentos oportunos e de evitar a manipulação indevida do CVD;

3.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS

3.2.1 INSERÇÃO DO CATETER VESICAL DE DEMORA

✓ **Seleção do cateter**

- Utilizar cateter de menor calibre possível, mas que permita drenagem eficaz, reduzindo possíveis riscos de trauma uretral;
- Escolher o calibre do cateter considerando a idade e anatomia do paciente, visando reduzir risco de trauma uretral;
- Optar por cateter de silicone em casos de uso prolongado (menor risco de incrustações);
- Utilizar cateter de três vias e casos de necessidade de irrigação vesical.

✓ **Escolha do sistema de drenagem**

- Utilizar sistema fechado e estéril com válvula antirrefluxo;

✓ **Inserção do cateter**

- Realizar higiene das mãos antes da inserção e após qualquer manipulação do sistema;
- Utilizar técnica asséptica (uso de luvas estéreis, campo cirúrgico estéril, antisséptico e lubrificante estéril de uso único);
- Garantir que o procedimento seja realizado por profissional capacitado e treinado, acompanhado de outro membro da equipe, para auxílio durante o posicionamento adequado do paciente, prevenindo assim, possíveis contaminações;
- Limitar o número de tentativas de inserção do cateter.

- Realizar lubrificação adequada da uretra com lubrificante estéril e com lubrificante em volume adequado afim de evitar lesão e estenose uretral;
- Identificar a bolsa coletora da seguinte forma: responsável pela inserção, data da inserção, volume de insuflação do balonete e calibre do cateter;
- Marcar o limite máximo de enchimento da bolsa em 2/3 da sua capacidade.

✓ **Monitoramento da inserção**

- Preencher checklist de inserção de CVD no momento da inserção por outro profissional, verificando se todas as etapas estão sendo realizadas adequadamente;
- Registrar checklist de inserção de CVD no prontuário eletrônico do paciente (SOUL MV);

✓ **Irrigação**

- Utilizar irrigação em casos de obstrução, ou em alguns tipos cirurgias (como as prostáticas) ou instilação medicamentosa, evitando realizar de forma rotineira;
- Utilizar cateter de 3 vias quando houver indicação de irrigação pós-operatória;
- Realizar manipulação com técnica asséptica rigorosa em todas as eta pas do processo;
- Em caso de obstrução, utilizar seringa de 60 mL com bico longo e solução estéril, com técnica estéril (luvas e campo estéreis);
- Avaliar necessidade de troca por cateter de maior calibre em casos de obstruções re correntes;
- Irrigações com antimicrobianos ou uso de antissépticos/antibióticos tópicos são contraindicados por ausência de evidências de eficácia e risco de resistência bacteriana.

✓ **Fixação do cateter**

- Realizar fixação em local que permita mobilidade do paciente sem causar tração ou dobras no cateter, como em região inguinal, coxa ou suprapúbica;
- Trocar fixação diariamente, alternando os locais de fixação para reduzir riscos de atrito e lesão por dispositivos.

✓ **Registro em prontuário**

- Registrar data e hora da inserção, nome do profissional responsável, calibre do CVD, volume de insuflação do balonete e local da fixação.

✓ **Envolvimento da família e do paciente**

- Fornecer orientações ao paciente, familiar ou acompanhante sobre o procedimento e acerca dos cuidados relacionados ao sistema de drenagem.

3.2.2 MANUTENÇÃO, MANUSEIO E TROCA DO CVD

✓ **Avaliação diária da necessidade de manter o cateter**

- Avaliar diariamente a indicação e necessidade de manter o cateter vesical de demora;
- Discutir sobre a necessidade da manutenção do cateter, nas visitas da equipe multiprofissional;
- Registrar no prontuário, durante a evolução, o número de dias de uso do cateter vesical de demora.

✓ **Higiene das mãos e uso de EPIs**

- Higienizar as mãos antes e após qualquer manipulação do cateter ou bolsa coletora;

- Utilizar óculos de proteção, máscara cirúrgica e luvas de procedimento em situações com risco de contato com urina.

✓ **Fixação do cateter**

- Avaliar diariamente a fixação do cateter;
- Manter o cateter vesical de demora fixado de maneira adequada para evitar lesões ou tração de uretra;
- Alternar o local de fixação para prevenir lesões relacionadas a dispositivos.

✓ **Cuidados com o meato urinário e região perineal**

- Realizar higiene íntima diária durante o banho e quando necessário;
- Durante a higiene, avaliar presença de lesões ou posicionamento inadequado do cateter.

✓ **Coleta de urina para exame**

- Realizar coleta com técnica asséptica;
- Realizar desinfecção do ponto/porta de coleta com álcool 70% antes da aspiração com seringa e agulha estéril (preferencialmente agulha sem corte);
- Encaminhar imediatamente a amostra ao laboratório para cultura;
- Para exames com grandes volumes (ex: proteinúria de 24h), coletar pelo bico de drenagem da bolsa coletora, de forma asséptica.

✓ **Sistema de drena gem**

- Manter sistema fechado e estéril;
- Manter fluxo urinário contínuo e desobstruído, mantendo o cateter e sistema de drenagem sem dobras.
- Manter a bolsa identificada com data da inserçao do dispositivo, calibre do cateter, marcação do limite de 2/3 da capacidade e nome do profissional responsável;
- Evitar contato com chão, parede ou outras superfícies;
- Não posicionar em locais com risco de tração (ex.: grades de leito);
- Manter sempre abaixo do nível da bexiga;
- Não clampear a extensão durante transporte, mobilização ou deambulação;
- Após mobilização do paciente, verificar se o sistema está desdobrado e bem-posicionado.

✓ **Esvaziamento da bolsa coletora**

- Esvaziar, no mínimo, a cada turno, ou antes, se atingir 2/3 da capacidade;
- Utilizar recipiente limpo, exclusivo e individual por paciente;
- Trocar luvas e higienizar as mãos entre pacientes;
- Manter clamp distal fechado, inclusive em casos com irrigação vesical;
- Evitar contato do bico de drenagem com o recipiente e outras super fícies para prevenir riscos de cotaminações;
- Registrar em prontuário horário, volume desprezado, aspecto da urina e anormalidades.

✓ **Indicação para troca de cateter (realizar a troca de todo o sistema)**

- Avaliar a necessidade de troca do sistema apenas em casos de:
  - − obstrução do cateter ou tubo coletor;
  - − desconexão, quebra de técnica asséptica ou vazamento;
  - − incrustações visíveis ou presença de depósitos que dificultem o es vaziamento vesical;
  - − mau funcionamento do cateter;
  - − sinais de infecção local, conforme critérios diagnósticos (ANVISA, 2025);
  - − troca programada conforme validade e recomendação do fabricante.
- Em pacientes transferidos de outras unidades com CVD, avaliar ne cessidade de manutenção ou retirada;
- Realizar troca apenas se houver más condições do dispositivo ou suspeita de ITU;
- Caso haja necessidade de troca de algum componente, todo o sistema deve ser trocado.

✓ **Manutenção e manuseio do cateter e sistema de drenagem**

- Preencher diariamente no prontuário eletrônico checklist de manutenção de CVD;

✓ **Registrar em prontuário**

- Indicação do CVD e profissional responsável;
- Data, hora e profissional que realizou a inserção;
- Avaliações diárias da necessidade de permanência;
- Volume e aspecto da urina desprezada;
- Condição do meato uretral após higienização e troca de fixação;
- Sinais e sintomas de infecção do trato urinário;
- Datas de retirada e troca do cateter.

3.2.3 RETIRADA DO CATETER

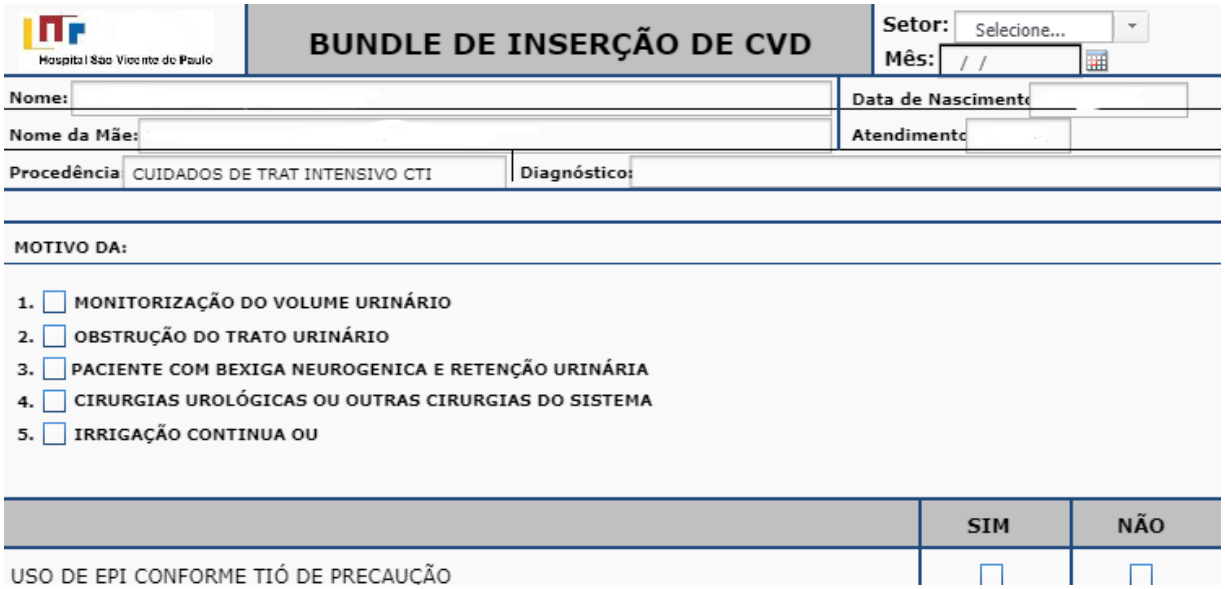
✓ **Retirada do cateter**

- Não realizar fechamento prévio do cateter;

✓ **Registro em prontuário**

- Registrar no prontuário: data e hora da retirada e possíveis intercorrências.

4. ILUSTRAÇÕES/ ANEXO I



Hospital São Vicente de Paulo

BUNDLE DE INSERÇÃO DE CVD

Setor: Selecione...
Mês: / /

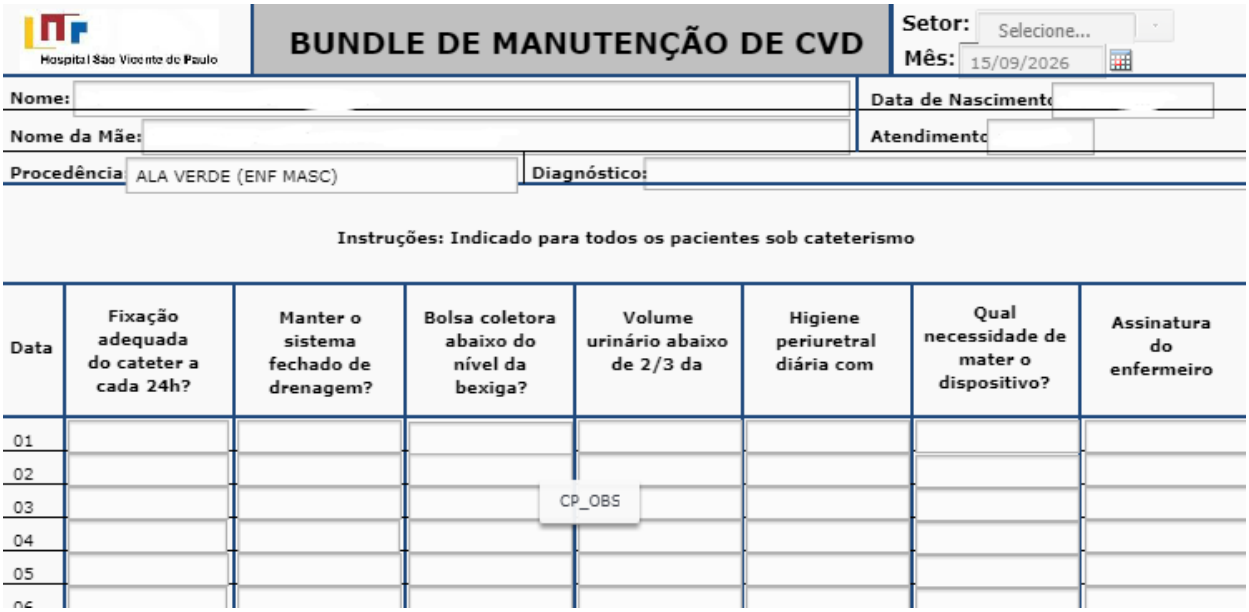
Nome:
Data de Nascimento
Nome da Mãe:
Atendimento
Procedência: CUIDADOS DE TRAT INTENSIVO CTI
Diagnóstico:

MOTIVO DA:

1. ☐ MONITORIZAÇÃO DO VOLUME URINÁRIO
2. ☐ OBSTRUÇÃO DO TRATO URINÁRIO
3. ☐ PACIENTE COM BEXIGA NEUROGENICA E RETENÇÃO URINÁRIA
4. ☐ CIRURGIAS UROLÓGICAS OU OUTRAS CIRURGIAS DO SISTEMA
5. ☐ IRRIGAÇÃO CONTINUA OU

	SIM	NÃO
USO DE EPI CONFORME TIÓ DE PRECAUÇÃO	☐	☐

5. ILUSTRAÇÕES/ ANEXO II



Hospital São Vicente de Paulo

BUNDLE DE MANUTENÇÃO DE CVD

Setor: Selecione...

Mês: 15/09/2026

Nome:

Data de Nascimento

Nome da Mãe:

Atendimento

Procedência: ALA VERDE (ENF MASC)

Diagnóstico:

Instruções: Indicado para todos os pacientes sob cateterismo

Data	Fixação adequada do cateter a cada 24h?	Manter o sistema fechado de drenagem?	Bolsa coletora abaixo do nível da bexiga?	Volume urinário abaixo de 2/3 da	Higiene periuretral diária com	Qual necessidade de mater o dispositivo?	Assinatura do enfermeiro
01							
02							
03							
04							
05							
06							

CP_OBS

7. REFERÊNCIAS

1. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/HIMJ_protocolo_ITU_1254773676.pdfhttps://www.hcor.com.br/area-medica/wp-content/uploads/sites/3/2021/12/PROTOCOLOS_PRONTO_SOCORRO_INFECCAO_TRATO_URINARIO_v2_web-1.pdf
2. https://sogirgs.org.br/area-do-associado/Infeccao-do-trato-urinario-2021.pdf
3. https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/Pathways/Infeccao-do-Trato-Urinario.pdf
4. https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-geniturin%C3%A1rios/infec%C3%A7%C3%B5es-do-trato-urin%C3%A1rio/infec%C3%A7%C3%B5es-bacterianas-do-trato-
5. https://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-and-asymptomatic-bacteriuria-in-pregnancy?search=infeccao%20urinaria%20and%20cultura%20de%20controle&source=search_result&selectedTitle=3%7E150&usage_type=default&display_rank=2#H10urin%C3%A1rio#Diagn%C3%B3stico_v1052863_pt
6. https://www.uptodate.com/contents/acute-complicated-urinary-tract-infection-including-pyelonephritis-in-adults-and-adolescents?sectionName=Directed%20antimicrobial%20therapy&search=infeccao%20urinaria%20and%20cultura%20de%20controle&topicRef=8065&anchor=H945200358&source=see_link#H945200358
7. https://www.hupe.uerj.br/wp-content/uploads/2023/07/Manual-para-Preparo-e-Administra%C3%A7%C3%A3o-de-Medicamentos-Intravenosos_Final_02jul23-1.pdf
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9598998/
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33309610/
10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30094687/
11. https://www.ics.org/2023/abstract/426
12. https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340026535PNG_RIAE_Longa.pdf
13. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília, DF: Anvisa, 2026.

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO		
VERSÃO	**DATA**	**DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO**
01	15/05/2025	Elaboração
01	15/05/2025	Aprovação e publicação
02	30/05/2026	Atualização

Versão 1 – Elaboração Júlia R. Chaves P.Leite Ana Carolina Gomes de Farias	Data: 31/05/2025
Versão 2 – Atualização Júlia R. Chaves P.Leite Ana Carolina Gomes de Farias	Data: 31/05/2026
Validação/Revisão Nayanne Ingridi F. Mota Guerra Giuliana Marçal Matheus Soares	
Aprovação Matheus Soares Sônia da Silva Delgado	